

 	Hôpital Bicêtre	Procédure Réf : smq-reference Version : 1 Date d'application : smq-dateapplication Date de fin de validité : smq-limval Page 1 sur 9
	PROTOCOLE : MISE EN POSTURE CHIRURGICALE DOUBLE ÉQUIPE SUR JAMBIÈRES MOBILES	

	NOM, FONCTION	DATE
RÉDACTION	Bouix jean	12/02/26
VALIDATION		Date de validation
APPROBATION	smq-approbateurs	Date d'approbation

Groupe de travail : Installation en posture chirurgicale au bloc opératoire pluridisciplinaire dans le cadre des actes relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat

Principales modifications par rapport à la version précédente : smq-objet-modif

1. OBJET

Réalisation de l'installation définitive du patient en décubitus dorsal par l'infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat (IBODE) dans le cadre de sa compétence exclusive et en vue de l'intervention chirurgicale : nécessitant une installation en décubitus dorsal bras en croix ou avec 1 ou 2 bras le long du corps

Chirurgie bras en croix	Chirurgie bras droit le long du corps
Chirurgie 2 bras le long du corps	Chirurgie bras gauche le long du corps

2. DOMAINE D'APPLICATION

L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire est seule habilité à accomplir les actes ou activités, dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par les chirurgiens du bloc opératoire, sous réserve qu'un chirurgien puisse intervenir à tout moment : l'installation en posture chirurgicale au bloc opératoire pluridisciplinaire en dehors de la présence du chirurgien.

Cette procédure s'adresse aux Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d'Etat ayant validé la formation de 49 heures aux actes relevant de la compétence exclusive. Elle sera mise en œuvre au bloc opératoire et concernera l'ensemble des spécialités de chirurgie réalisées à l'hôpital Bicêtre pour le secteur de chirurgie viscérale et digestive.

Les Infirmiers en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peuvent participer en présence d'une IBODE à la réalisation et à la validation de l'installation en posture chirurgicale.

3. RESPONSABILITÉS/ PERSONNES CONCERNÉES

IBODE, IDE, étudiant IBODE, chirurgiens, internes en chirurgie, externe, MAR, IADE, aide-soignant, agent hospitalier.

4. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

CF DOCUMENT JOINT

5. INDICATION ET BUT

Installation provisoire en décubitus dorsal :

Le décubitus dorsal est une position standard de référence permettant de réaliser l'anesthésie. Elle est toujours la même mais peut être modulée selon le type d'anesthésie (ex : anesthésie locorégionale). Le patient est, la majeure partie du temps, en décubitus dorsal strict (la tête, le tronc et les jambes dans l'axe du corps) : - La tête repose sur un rond de tête en polymère viscoélastique pour le confort du patient,

- Les bras sont installés en abduction inférieure à 90° sur des appui-bras de chaque côté,
- Le patient est sanglé pour éviter les chutes au moment de l'induction,
- On propose au patient une couverture chauffante, afin d'éviter le risque d'hypothermie.

L'installation provisoire en décubitus dorsal permet d'assurer la sécurité, le confort et la pudeur du patient et de pouvoir « technique » le patient (intubation, dispositifs de surveillance, perfusion).

Installation définitive en décubitus dorsal avec les deux bras le long du corps

L'installation définitive en décubitus dorsal avec les deux bras le long du corps facilite l'abord chirurgical en chirurgie viscérale, car cela améliore l'exposition du site opératoire.

6. CONDUITE À TENIR

6.1 Matériel

- Une table d'opération standard.
- Un matelas antiglisser.
- Un rond de tête en gel viscoélastique standard.
- Deux alèses tissues
- Une sangle de maintien.
- Bas de contention si nécessaire.
- Couverture chauffante.

6.2 L'installation

6.2.1 Installation provisoire en décubitus dorsal strict

- La tête dans l'axe du corps sur un rond de tête viscoélastique,
- Les bras sur appui-bras en abduction inférieure à 90°, les mains en supination,
- Le thorax, bassin et jambes sont dans le même alignement,
- Le patient est d'emblée positionné à la bonne position sur la table d'opération.
- Une alèse tissue sur le matelas antiglisser parallèlement à la table.
- Une alèse tissue par-dessus perpendiculairement à la table au niveau dorsolombaire
- Une couverture chauffante dégageant la zone à opérer.
- Une sangle de maintien est positionnée au niveau de la ceinture pelvienne du patient.
- On peut placer sous les genoux du patient un billot afin de soulager le dos et d'améliorer la circulation veineuse des membres inférieurs, et des talonnettes en gel viscoélastique sous les talons du patient.

6.2.2 Installation définitive en position double équipe

- Le patient est installé en **décubitus dorsal strict**, en position centrée sur la table opératoire.
- La tête repose sur un **rond de tête en gel viscoélastique**, permettant un alignement neutre du rachis cervical avec le rachis dorsal.
- L'axe tête–cou–tronc–bassin est vérifié afin d'éviter toute rotation ou inclinaison.

6.2.3 a) Installation des membres supérieurs bras en croix

- Les deux bras sont sur appuis bras.
- Absence d'abduction, d'hyperextension ou de rotation forcée des épaules.
- Aucune traction du plexus brachial.
- Les coudes sont protégés (prévention de compression du nerf ulnaire).
- Les mains et poignets sont en position neutre.
- Une protection est interposée entre les bras et les appuis si nécessaire.
- Les bras sont maintenus sans compression excessive

6.2.3 b) Installation des membres supérieurs 1 bras le long du corps

Un bras est **positionné le long du corps**, en rectitude anatomique.

- La paumes de la main est placées contre les cuisses, en position neutre ou légère supination selon l'accessibilité du champ opératoire.
- L'épaule est maintenue en position physiologique, sans traction postérieure.
- Une protection par des interfaces est interposée au niveau :
 - Du coudes (prévention de compression du nerf ulnaire),
 - De la main si nécessaire.
- Le bras est maintenu à l'aide d'un drapage adapté sans compression excessive qui est replié sous le patient avec l'alèse transverses en évitant les plicatures.
- L'alèse protégeant la table est systématiquement retiré pour que le patient soit au contact du matelas antiglisse
- L'absence de contrainte sur le plexus brachial est systématiquement vérifiée (absence d'abduction forcée, d'hyperextension ou de compression).

6.2.3 c) Installation des membres supérieurs 2 bras le long du corps

- Les **deux bras sont positionnés le long du corps**, en rectitude anatomique.
- Les paumes des mains sont placées contre les cuisses, en position neutre ou légère supination selon l'accessibilité du champ opératoire.
- Les épaules sont maintenues en position physiologique, sans traction postérieure.
- Une protection par des interfaces est interposée au niveau :
 - Des coudes (prévention de compression du nerf ulnaire),
 - Des mains si nécessaire.
- Les bras sont maintenus à l'aide d'un drapage adapté sans compression excessive.
- Le bras est maintenu à l'aide d'un drapage adapté sans compression excessive qui est replié sous le patient avec l'alèse transverses en évitant les plicatures.
- L'alèse protégeant la table est systématiquement retiré pour que le patient soit au contact du matelas antiglisser
- L'absence de contrainte sur le plexus brachial est systématiquement vérifiée (absence d'abduction forcée, d'hyperextension ou de compression).

6.2.4 Installation du tronc

Un matelas antiglisser est installé sous le patient pour prévenir tout risque de glissade.

Le tronc est centré à la table

Les épaulières peuvent être placées si nécessaire

6.2.5 Positionnement des membres inférieurs

Les deux jambes sont placées en extension physiologique.

Un coussin peut être positionné sous les genoux afin de diminuer la tension lombaire si nécessaire.

Les chevilles sont protégées en cas de contact avec les accessoires de table.

6.2.6 Ajustements de table

La table opératoire peut être adaptée selon le temps chirurgical :

Proclive ou déclive,

Toute modification de position est réalisée après vérification :

- De la stabilité du patient,
- De l'absence de traction sur les membres,
- De l'intégrité des points d'appui.

6.3 Vérifications ultimes

6.3.1 Vérification médico-chirurgicale

Concordance entre :

- L'identité du patient.
- La chirurgie prévue.
- Le site opératoire et le côté si nécessaire.

6.3.2 Tête et rachis

- La tête est positionnée dans l'axe du corps, sans rotation ni extension du rachis cervical.
- Un rond de tête en gel viscoélastique adapté est correctement positionné.
- Les pavillons des oreilles ne sont ni plicaturés ni comprimés.
- Les yeux sont occlus et protégés.
- Absence de point d'appui occipital excessif.

6.3.3 a) Membres supérieurs (bras en croix)

- Les deux bras sont sur appuis bras.
- Absence d'abduction, d'hyperextension ou de rotation forcée des épaules.
- Aucune traction du plexus brachial.
- Les coudes sont protégés (prévention de compression du nerf ulnaire).
- Les mains et poignets sont en position neutre.
- Une protection est interposée entre les bras et les appuis si nécessaire.
- Les bras sont maintenus sans compression excessive

6.3.3 b) Membres supérieurs (1 bras le long du corps)

- Le bras est en rectitude anatomique, le long du tronc.
 - Absence d'abduction, d'hyperextension ou de rotation forcée des épaules.
 - Aucune traction du plexus brachial.
 - Les coudes est protégé (prévention de compression du nerf ulnaire).
 - Les mains et poignets sont en position neutre.
 - Une protection est interposée entre les bras et la table si nécessaire.
 - Le bras est maintenu sans compression excessive (vérification du drapage).
-
- Le bras controlatéral est sûr appuie bras
 - Absence d'abduction, d'hyperextension ou de rotation forcée des épaules.
 - Aucune traction du plexus brachial.

- Les coudes sont protégés (prévention de compression du nerf ulnaire).
- Les mains et poignets sont en position neutre.
- Une protection est interposée entre les bras et les appuis si nécessaire.
- Les bras sont maintenus sans compression excessive.

6.3.3 c) Membres supérieurs (2 bras le long du corps)

- Les bras sont en rectitude anatomique, le long du tronc.
- Absence d'abduction, d'hyperextension ou de rotation forcée des épaules.
- Aucune traction ni compression du plexus brachial.
- Les coudes sont protégés (prévention de compression du nerf ulnaire).
- Les mains et poignets sont en position neutre.
- Une protection en gel est interposée entre les bras et la table si nécessaire.
- Les bras sont maintenus sans compression excessive (vérification des bandes ou du drapage).

Dans tous les cas les mains sont protégées de tout contact avec les parties métalliques de la table opératoire

6.3.4 Tronc et appuis

- Alignement correct tête–rachis–bassin.
- Absence de compression thoracique.
- Les électrodes de monitoring ne sont pas situées sous un point d'appui.
- Les câbles et voies veineuses ne sont ni coudés ni comprimés.

6.3.5 Membres inférieurs

- Les deux jambes sur jambière.
- Absence de rotation excessive des hanches.
- Protection des points d'appui
- Absence de compression au niveau des mollets.
- Bas de contention ou dispositif de compression pneumatique en place si risque thromboembolique.

6.3.6 Prévention des risques peropératoires

- Le patient est réchauffé (couverture chauffante adaptée et positionnée en dehors du champ opératoire).
- La température du dispositif de réchauffement est adaptée à la température corporelle.
- Vérification de la stabilité du patient en cas de modification prévue de la table (proclive, déclive).

6.3.7 Sécurité finale

- Aucun point de compression identifié.
- Aucun matériel sous le patient.
- Installation validée par l'équipe avant le champage.

6.4 Désinstallation du patient en décubitus dorsal

La désinstallation est réalisée de manière progressive, coordonnée et sécurisée, en collaboration avec l'équipe anesthésique.

6.4.1 Coordination préalable

Validation par l'anesthésiste de la stabilité hémodynamique et respiratoire.
Vérification de l'arrêt des dispositifs chirurgicaux et du retrait du matériel stérile.
Anticipation du réveil et des éventuels mouvements réflexes.

Mise en place de la ceinture de maintien

6.4.2 Retrait des dispositifs de maintien

Retrait :

- Des épaulières si utilisées.

6.4.3 Membres supérieurs

Libération des bras du drapage ou des dispositifs de contention.
Vérification de :

- L'intégrité cutanée au niveau des coudes (zone du nerf ulnaire),
- L'absence de rougeur ou compression au niveau des épaules,
- La mobilité passive douce si le patient est encore sédaté.
- Les bras sont replacés en position neutre sécurisée avant transfert.

6.4.4 Membres inférieurs

Vérification des talons (risque d'escarre).
Retrait des dispositifs de compression pneumatique si présents.
Contrôle visuel des points d'appui (mollets, malléoles).

6.4.5 Tronc et points d'appui

Inspection des zones à risque :

- Occiput,

- Omoplates,
- Sacrum,
- Talons.

Vérification de l'absence de rougeur persistante, d'œdème ou de marque cutanée anormale.

6.4.6 Remise en position neutre

La table est remise en position horizontale.

Le patient est recentré si nécessaire.

Les dispositifs de réchauffement sont retirés ou laissés su besoin.

Les câbles et lignes sont sécurisés avant transfert.

6.4.7 Transfert du patient

Réalisé en coordination avec l'anesthésie.

Utilisation d'un drap de glisse ou d'un système d'aide au transfert.

Maintien de l'axe tête-cou-tronc pendant le transfert.

Surveillance des voies aériennes et des abords veineux.

6.4.6 Traçabilité

Notation dans le dossier :

Position opératoire,

Dispositifs de protection utilisés,

Absence ou présence de lésions cutanées,

Incidents éventuels liés à l'installation.

Schémas et photo